

GASTROLOGIE

Dr.KHERBA_N

GASTROLOGIE

Abcès périanal

Angiocholite / Cholécystite

Appendicite

Ascaridose

Colique hépatique

Colopathies fonctionnelles

Constipation

Crise hémorroïdaire

Diarrhées aiguës

Douleur abdominale

Dyspepsie

Fissure anale

Gastrite

Gastroentérite

Hépatites

Hoquet

Ingestion de caustique

Ingestion de l'eau Javel

Ingestion d'une pièce de monnaie

Ingestion d'une pile

Intoxication alimentaire

Maladie coéliquue

Occlusion intestinale aigue

Omphalite

Oxyurose

Pancréatite

Péritonite

RGO

Rupture des varices œsophagiennes

Spasme

UGD

Vomissements

Abcès périanal

1 Oxacilline cp 500mg 2cp 2/j pdt 10j Ou
Ciprofon

2 Flagyl cp 500mg 1cp 3/j pdt 10j

3 KMnO₄ 1cp dans 5l d'eau tiède après
chaque selle

Ou

1 Cefacet cp 1g 1cp 2/j pdt 7j

2 Genta inj pdt 5j Ou Cefacidal inj 1g pdt 8j

3 Flagyl cp 500mg

4 Codoliprane

+/_ Échographie des parties molles

Abcès anal

■ Non collecté :

1 Cefacet cp 1g 1cp 3/j pdt 10j

2 Doliprane cp 1g 1cp 3/j

■ Collecté : Drainage

Angiocholite Cholécystite

● Angiocholite :

Douleur abdominale intense + fièvre + ictère

▪ Echographie

● Cholécystite :

Douleur de HCD + signe de Murphy (+) irradie en bretelle vers les épaules, déclenchée par un repas copieux riche en graisses

▪ Echographie

→ Avis chirurgie générale

✓ Traitement :

- Clamoxyl cp 1g 1cp pdt 10j
- Flagyl cp 500mg pdt 10j
- Spasfon cp 80mg 1cp 2_3/j
- Paracétamol 1g 3/j
- Réhydratation :

SSI 1500cc

SGL 1500cc

Cholécystite aiguë multilithiasiques

● Rechercher des signes de complications :

Triade de Charcot ou Hyperalgique

✓ Antalgique + Double ATB (Cefa + Flagyl)

■ Échographie A/P

■ Bilan :

■ Glycémie à jeun

■ FNS

■ CRP

■ Hépatique

■ Lipidique

→ Avis de chirurgie générale

Appendicite

● Clinique :

Sensibilité douloureuse au niveau FID,
défense localisée + fièvre +/-

vomissements, amaigrissement

Douleur colique brutale intense

■ Echographie

■ TR=> +/- douloureux

■ Bilan :

■ FNS : Hyperleucocytose à PNN

■ CRP+++

■ VS ↗

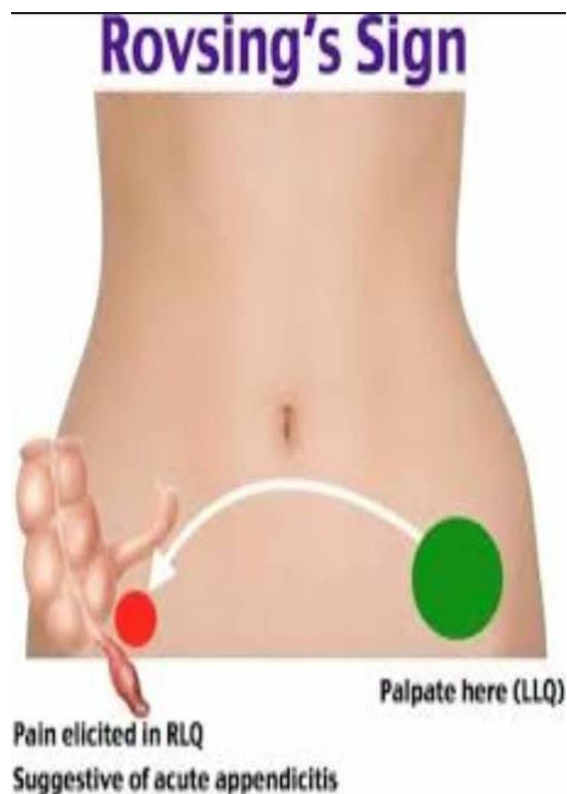
✓ Traitement :

■ Antalgique/Antipyrétique

■ Poche de glace

⊖ AINS sont CI

→ Orientation Chirurgie



Ascaridiose

● Clinique:

Souvent asymptomatique, parfois dyspepsie

- Confirmer par la coproculture des selles
- FNS: Hyperéosinophilie

✓ Traitement:

- 1 Verten 400 1cp/j au moment de repas
- 2 Spasfon si douleur abdominale

- RHD
- Traitement de l'entourage

Colique hépatique

● Clinique :

- Douleur brutale intense HCD en regard du foie, déclenchée par un repas copieux riche en graisses, irradie vers l'épaule homolatéral, fièvre
- Signe de Murphy +
- Diagnostic différentiel CN qui irradie vers les organes génitaux.

✓ CAT :

- O2/VVP
 - Spasfon 1amp en IVD
- Ou Perfalgan 1flc en IVL

Ou Spasfon 2amp diluées dans 150cc SSI ou SG5% 30min

✓ Traitement de sortie :

1 Spasfon lyoc 80mg 1lyoc 2/j

2 Débridat 200cp 1cp 2/j pdt 5j

Ou Dusphatalin gel 200mg 1gel 2/j

Ou Spascol gel 200mg 1gel 2/j

■ Si vomissements :

Domperidone cp 1cp 2/j 15min avant repas

Ou Clopramide cp

■ Bilan : 

■ FNS/Gly

■ CRP/VS

■ ASAT/ALAT/GT/PA

■ BT/BD/BI

■ Lipasémie

■ Échographie AP

 Hospitalisation si :

- Douleur + Fièvre => Cholécystite
- Douleur + Fièvre + Ictère => Angiocholite

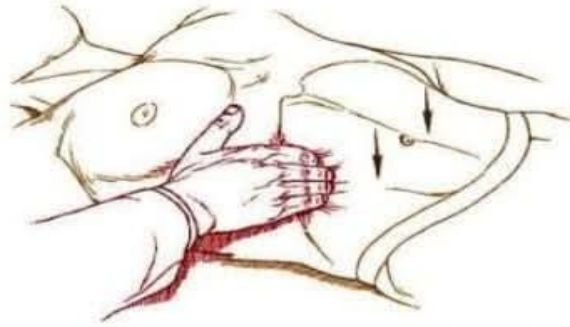
 ATB + Avis Chirurgie en urgence !

- Spasfon/8h
- Perfalgan/8h
- SSI/8h
- Primperan/12h
- ATB : Flagyl 500mg/12h
- Ciprofloxacin 200mg 2/j

Ou Bactrim Ou Augmentin 1g 2_3/j

Signe de Murphy

c'est une douleur provoquée lors d'une
inspiration profonde, par la palpation
sous le rebord costal droit (aire vésiculaire)
signe d'une cholécystite Aigue



Colopathies fonctionnelles

- Diarrhées => Coproparasitologie des selles
- Diarrhées fréquentes => Maladie cœliaque (IgA antiTG)
- Constipation => TSH/T4
- Douleur localisée => Echographie

 En urgence :

Sapsfon 1 amp en IM

☒ Traitement de sortie :

☐ 1 Spasfon cp 1cp 2/j

Spascol gel 200 1gel 3/j

☐ 2 Débridat cp 200mg 1cp 2/j

Ou Dusphatalin gel 200mg 1gel 2/j

Ou Transcalm gel 200mg 1gel 2/j

3 Duphalac (constipation) st 1st 2/j

Ou Esilax sirop 1cas 2/j

4 Imoduim (diarrhées) gel 2mg 2gel/j

Après chaque diarrhée peut ajouter 1gel

Bedelix (pansement gastrique) st 1st 2/j

Eucarbon (gaz) cp 1cp 2/j

Free gaz 2cp 2/j après repas

Charbonel plus capsule 1 cap 2/j

Meteoxane gel 2gel 3/j

Simexane gel 2gel 2/j

+ Vitamag amp 1amp/j

Ou Solyne Mg

■ Femme enceinte  :

1 Constipation :

Ezilax sirop ou Glycérine suppo 1suppo/j

2 Gaz/Balonnements :

Effidigest st 1st 1/j ou Digerme gel 1_2gel/j

3 Antispasmodique :

Dusphatalin

■ Enfant  :

1 Débridat sirop

2 Spasfon lyoc

Constipation

● Clinique :

Selles rares, difficiles, douloureuse, dures..

- Organique digestive :
 - Maladie cœliaque (IgA antiTG)
 - Mucoviscidose (test de la sueur)
 - Malformation (échographie)
- Organique extra digestive : HypoK, HyperCa,
 - Hypothyroïdie, Diabète insipide, Médicaments..
- Fonctionnel 90% : pas AEG

⊖ Organique à explorer puis traiter

Fonctionnel traiter sans explorer

 Si constipation + météorisme,
vomissements, AEG, sévère ou résistante au
traitement :

- TR
- ASP
- Échographie AP
- Ionogramme Ca
- Bilan thyroïdien TSH=> Hypothyroïdie
- Bilan rénal
- Lavement barté
- Test de sueur
- Colposcopie
- Manométrie anorectal voir Biopsie

✓ CAT :

- Eliminer l'urgence
- RHD : régime riche en légumes
Éviter le riz, chocolat, carottes..

■ Laxatifs lubrifiants :

- Huile de paraffine sirop à éviter chez NRS

<1ans=> 1cac/j

1_6ans=> 2cac/j

>6ans=> 3cac/j

■ Laxatifs osmotiques :

- Lacutolose sirop ou

Forlax st : 4_10g

6mois_1ans=> 1st 4g/j

1_4ans=> 2st 4g/j

4_8ans=> 2_4st 4g/j

>8ans=> 1_2st 10g/j

■ Modificateurs du peristaltisme :

■ Débridat : <6mois=> 1/2cac 3/j

6mois_1ans=> 1cac 2/j

1_5ans=> 1cac 3/j

>5ans=> 2cac 3/j

■ Anticonstipants chez l'adulte :

■ Duphalac sirop 1cac 2/j

■ Duphalac st 1st 3/j avant repas

■ Ponctuel gtt 20gtt dans un verre d'eau

■ Ezilax sirop 1cam 1/j

■ Débridat (Trimebutine) cp 100mg 1cp 2_3/j

■ Bedelix st 1st 3/j

■ Huile de paraffine sirop 1cam 2/j

■ Spasfon Lyoc 80mg 1lyoc 3/j

■ Forlax st 4mg=> E 10mg=> A 1st 3/j

■ Regulax ou Noramcol tube rectal 1/j

Un verre d'eau matin à jeûne + 1cac de huile d'olive le soir.

■ Femme enceinte  :

■ Ezilax sirop 1cac 2/j

Ou Forlax st

■ Diabétique :

■ Ponctuel gtt 15_20gtt/j

Ou Forlax

Ou Normalax

Ou Huile de paraffine

■ Enfant 🧒 :

1 Débridat sirop 1ddp 3/j

Ou si E>12ans Trimebutine cp 1cp 2/j

2 Duphalac sirop 4g :

<1ans=>1cac 1/j

1_6ans=>1cac 2/j

>6ans=>1cac 3/j

Ou Forlax st

Ou Glycérine suppo 1/2suppo 1_2/j

Crise hémorroïdaire

Clinique :

- Rectosegmoïdoscopie en 1er confirme le diagnostic et élimine une tumeur.
- Traitement selon stade:
- 1 et 2=> médical
- 3=> médical ou instrumental
- 4=> instrumental ou chirurgie

CAT:

Voltarene 1amp en IM

+ Spasfon 1amp en IM ou IVD

Ou Perfalgan 1flc en IVL

+ Clofenal 1amp en IM

✓ Traitement de sortie :

- 1- Antalgique (AINS et Paracétamol)
- 2- Veinotoniques
- 3- Application locale (Tétanoréine..)
- 4- Traitement de constipation
- 5- Traiter le côlon nerveux (Duspatalin, Débridat..)
- 6- Alimentation riche en fibres, Hydratation 1,5_2l/j

⊖ Si on prescrit un AINS toujours on fait l'associé avec un IPP

De préférence on évite les AINS

■ Un traitement plus efficace que Daflon:

Daflav fort gel 2gel 2/j pdt 7j

■ Ordonnance 1:

1 Daflon cp 500mg pdt 1mois

2cp 2/j pdt 10j

1cp 2/j le reste des j

Ou 3g pdt 3j soit 2cp 3/j

2g pdt 3j soit 2cp 2/j

1g pdt 4j soit 1cp 2/j

Ou 3cp 2/j pdt 4j

2cp 2/j pdt 3j

1cp 2/j pdt 3j

Ou Dioveine 600mg cp 2/j

2 Titanoreine à hidocaïne suppo 1suppo/j le soir

3 Titanoreine à hidocaïne pmd 2% 2app/j après toilette anale

4 Duphalac st 1st 1_2/j

5 Divido cp 75mg 1cp/j le soir

■ Ordonnance 2:

- 1 Diovenor cp 600mg 1cp 3/j pdt 10j
- 2 Hemorect crème 1app/j
- 3 KMnO4 cp pour bain de siège 10_15mn 2/j
- 4 Ezilax sirop 1cac 2/j
- 5 Rapidus cp 50mg 1cp 2/j au milieu de repas

■ Ordonnance 3:

- 1 Veinosmil gel 200mg 2gel 2/j pdt5j
- 2 Hemolog/Hemorro_fix crème 1app/j
- 3 Hemolog suppo 1suppo/j le soir
- 4 Ponctuel gtt 6gtt/j
- 5 Clofenal cp 100 1cp/j au milieu de repas

■ Ordonnance 4:

- 1 Cyclo 3 fort gel 2gel 2/j
- 2 Néo healer/Sito_heal pmd 1app/j
- 3 Trimebutine suppo 1suppo/j
- 4 Voltarene cp50mg 1cp 2/j au milieu de repas

■ Ordonnance 5:

- 1 Daflon cp 500mg 2cp 2/j pdt 7j
- 2 Proctolon suppo 1suppo 2/j
- 3 Forlax st 2st le matin
- 4 KMnO4 bain de siège 1cp dans 5L d'eau.

■ Femme enceinte :

1 Nitral plus crème Ou Hemo plus crème

Ou Hemorrol crème 1 app/j pdt 10j

2 Paracétamol si douleur

3 Forlax ou Ezilax si Constipation

4 Huile de lentisque le matin

■ Bilan:  de retentissement si saignement

■ FNS/Ferritinémie

■ Régime alimentaire riche en fibres, activités physiques, éviter le debout prolongé, assis, épices, café, thé..

→ Avis Gastrologie => Rectoscopie

Stade I	Hémorroïdes Symptomatiques sans extériorisation
Stade II	Hémorroïdes Symptomatiques avec extériorisation lors de la défécation
Stade III	Hémorroïdes Symptomatiques avec extériorisation franche à la défécation ou à l'effort, nécessitant une réduction manuelle
Stade IV	Hémorroïdes Symptomatiques avec extériorisation permanente non réductible (prolapsus hémorroïdaire)

Diarrhées aiguës

● Clinique :

■ Étiologies Gastroentérite :

■ Virales 80% :

Selles aqueuses ni glaires ni sang

+/_ symptômes respiratoire et ORL

■ Bactériennes :

Fièvre, glaires, sanglantes, signes neurologiques, douleur abdominale.

■ Nourrisson :

↗ du nombre des selles :

>3 si lait artificiel

4_6 si lait maternel

- Coproculture si :
- Retour de voyage en zone d'endémie
- Prolongée >5j
- Déshydratation sévère
- Glairo sanglante sévère
- Terrain : VIH..

✓ CAT :

- Déshydratation <10%=> Ambulatoire
- Réhydratation orale par SRO 10cc/kg
<2ans : 50_100cc/kg après chaque selle ou vomissements
2_10ans : 100_200cc/kg
- <3mois : poursuit le lait maternel
- >3mois : lait habituel ou pauvre en lactose
- Si Diversification : eau de riz

⊖ Les nourrissons sous allaitement maternel :

Diarrhées sont physiologiques (selle après chaque tété)

■ Déshydratation >10%=> Hospitalisation

Antipyrétique + Antisécrétoire

Loperamide >2ans : Imoduim gtt 2gtt 2/j

Acetorphan : Tiorfan st

■ ATB : si fièvre, syndrome inflammatoire ou glairo sanglant

■ Diarrhée aigue liquide :

1 Smecta st :

2_6ans 1st 2/j

>6ans 1st 3/j

1 Tiorfan st

10mg : 1_9mois=>1st 3/j

9_30mois=>2st 3/j

30mg : 30mois_9ans=>1st 3/j

>9ans=>2st 3/j

2 SRO St 1st dans 1l d'eau brouiller puis
refroidir après chaque selle

<2ans=>5% 50cc/kg/j

>2ans=>10% 100cc/kg/j

■ Diarrhée glairo sanglante (Dysenterie) : si
fièvre => Bactrim

1 Bactrim sirop 240 1cam 2/j pdt 7j 30mg/kg/j

Ou Flagyl sirop 125_250 1cam 2/j pdt 7j
30mg/kg/j

2 SRO St

⊖ CI des ralentisseurs de transit : ex=>

Imodium (Loperamide) : Diaryl, Dimepra

Antidiarrhéiques sont CI en cas des diarrhées
glairosanglantes

Diarrhée secondaire aux ATB :

Smecta + Ultrabiotique

🏠 Si fièvre => Hospitalisation

1 Flagyl inj/12h 20mg/kg/j

Ou Bactrim 6_30 perfusion 0.2cc/kg 2/j

Ou Amoxicilline inj 100_120mg/kg/j 2/j

Ou Augmentin ou Claforan

2 Perfalgan pédiatrique/18h

■Adulte

■Diarrhée aqueuse virale :

Erceforyl gel 20mg 1gel 3/j

Ou Smecta st 1st 3/j

■Diarrhée glairo sanglante bactérienne :

[1] Bactrim cp 960mg 2cp 2/j à 12h d'intervalle
pdt 7j

⊖ CI d'associer avec Vomiteb risque de TDR

[2] Smecta st 1st 3/j

[3] Débridat cp 400mg 1cp 3/j

Ou Dusphatalin gel 200mg 1gel 3/j

■Femme enceinte :

Loperamide => Imodium, Dimpera gel

■Allaitement : Dimepra 2mg 2/j, Diaryl

Diarrhées post_antibiotique

● Diarrhée survenue après un traitement par amoxicilline_acide clavulanique (Augmentin®), surtout sans autres signes infectieux

- Début quelques jours à 2 semaines après l'arrêt de l'ATB
- Diarrhée aqueuse, non sanglante, non douloureuse
- Pas de fièvre, pas d'altération de l'état général
- Examen clinique et paraclinique rassurants
- ATB suspect : Augmentin®, Clindamycine, Céphalosporines.

- Coproparasitologie : négative (levures fréquentes et non pathogènes ici)
- CRP/VS/Ionogramme : normaux
- Pas d'hyperleucocytose ni de syndrome inflammatoire

✓ CAT:

- Arrêt strict de l'antibiotique causal
- Arrêt des antidiarrhéiques (déjà conseillé)
- Réhydratation orale
- Probiotiques : recommandés dans ce contexte
- Régime alimentaire adapté (pauvre en fibres, éviter laitages, jus, crudités..)

Douleur abdominale

- Siège :
- Epigastrique=> UGD, pancréatite aigue
- FID=> Appendicite aigue, colique néphrétique, annexes
- HCD=> Hépatobiliaire, pancréatique, ulcéreuse, colon droit
- Périombilicale=> Pancréatite, Occlusion, infarctus EM, Appendicite, Péritonite, colite
- FIG=> annexes, colique néphrétique, volvulus, sigmoïdite, colon pelvien
- Hypogastrique=> cystites, salpingites, annexes
- Diffuse=> Occlusion, pancréatite, péritonite, infarctus EM, intoxication alimentaire

■ Irradiation :

- Postérieur : épigastrique, coup de poignard=> Pancréatite et UGD perforée

- Vers angle costo vertébrale droit remontant à la pointe de l'omoplate=> Hépatobiliaire

- Vers les lombes et descendante=> Colique néphrétique et infection urinaire

- Scapulaire haute : à droite=> Hépatobiliaire

A gauche=> Pancréatite et GEU

↗ Marche, Toux, inspiration profonde, alimentation=> Cholécystite, pancréatite, Occlusion

↘

- Alimentation : UGD

- Vomissements : Occlusion, Cholécystite, Pancréatite

- Antéflexion : Pancréatite, crise hyper algique d'ulcère

- Facteurs déclenchants :
- AINS=> Ulcère
- Alcool=> Ulcère, Pancréatite
- Repas copieux=> Colique hépatique, Pancréatite
- Défense : contraction douloureuse déclenchée par la palpation
- Contracture : contraction spontanée irréversible

- Bilan : 
- FNS
- Lipasémie
- Amylasémie
- Ionogramme : si Occlusion ou Péritonite
- ASP
- Échographie AP
- Scanner

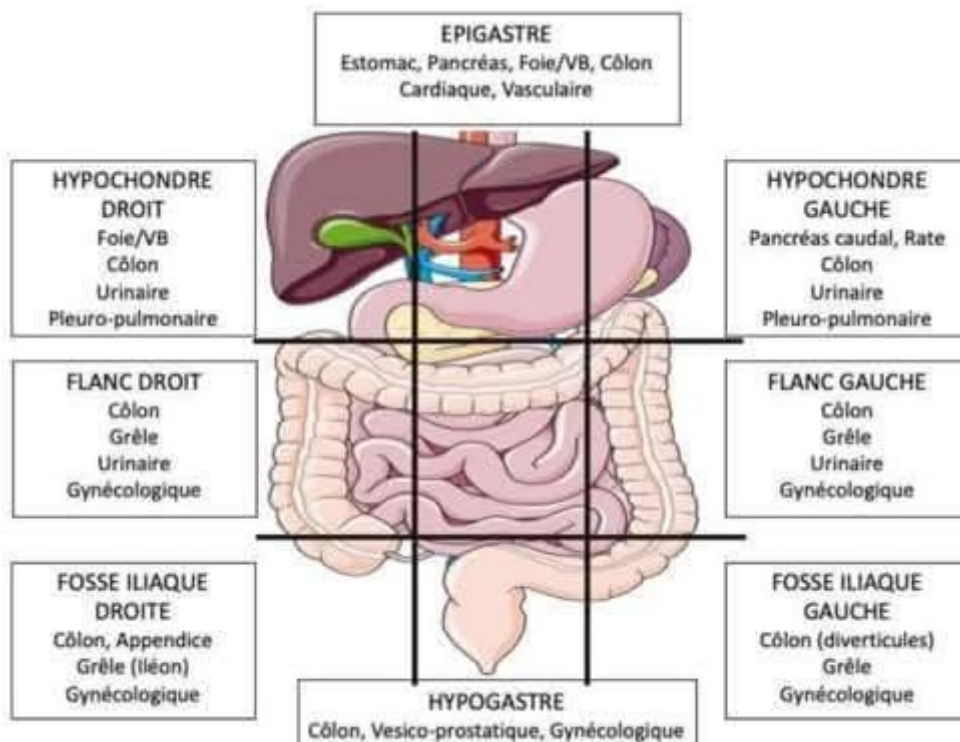


Figure 2 : Orientation étiologique des douleurs abdominales en fonction du siège

Dyspepsie fonctionnelle

● Clinique:

Impression de « mal digérer », des douleurs du creux de l'estomac et des ballonnements...

✓ Traitement:

1 Gaviscon st 1 st 3/j après repas

2 Omeprazole gel 20mg 1 gel 1/j soir avant repas

3 Domperidone +++ cp 10mg 1cp 2_3/j 15min avant repas

Ou Primperan

Fissure anale

● Clinique :

Plaie due à la déchirure de la peau qui recouvre la partie basse de l'anus, sous forme d'une raquette

Douleur anale, réctorragies, suintement, prurit, constipation réflexe..

Spasme sphinctérien (hypertonie), ulcérations

✓ Traitement :

1 Nitral/Hémo plus 1 app 3/j

Ou Hemorro_fix/ Sito_heal

2 Forlax st 1st/j

3 Xylocaïn gel 2% 1 app 2/j

4 KMnO4 bain de siège

1 Nifédipine crème 0.2% 2/j après les bains de siège

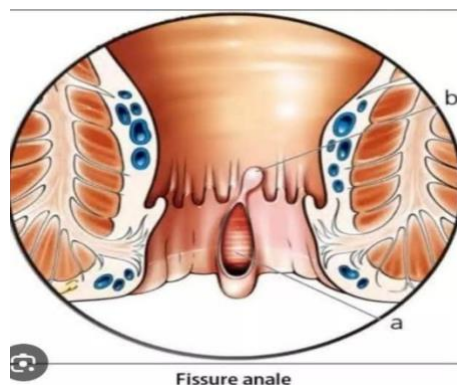
2 Lidocaïne gel 5% 1app 2/j (matin et soir avant les selles)

3 Magrocol 1app/j le matin

4 Paracétamol si douleur 500mg 1cp 2/j

■ Pommade pour la cicatrisation :

■ Hemorrol/Cicatrine



Gastrite

● Clinique :

- Sensation de brûlures, dyspepsie

Anémie ferriprive récidivante, purpura PTI

Douleur épigastrique soulagée par l'alimentation ou IPP

- Rechercher une prise des AINS, CTC

- FNS

- ASP : pour éliminer une perforation (qui CI la FOGD)

- Sujet jeune=> Sérologie Hb

- Âgé=> FOGD +/- Biopsie

Gastroentérite

● Clinique :

Douleur épigastrique + vomissements +
diarrhées

✓ Traitement :

1 Erceforyl gel 200mg 2cp 2/j

Ou Smecta st 1st 3/j

2 Spasfon cp 160mg 1cp 3/j

3 Domperidone sirop 1cas 3/j

+/_Flagyl cp 500mg 1cp 3/j

■ ATB si :

■ Clinique sévère

■ Fièvre prolongée 48_72h

■ Diarrhées glairosanglantes

- Signes de déshydratation
- Bilan : FNS/CRP perturbé
- Terrain immunodépression

■ Enfant 🧒

1 Tiopam : Durée max : 7j 1.5mg/kg par prise

■ Sachet : 1sac 3/j

■ <15kg : 10mg

1_9mois : 1sac 3/j

9_30mois : 2sac 3/j

■ >15kg : 30mg

30mois_9ans : 1sac 3/j

>9ans : 2sac 3/j

2 Vomiteb : CI <1ans Sirop : 1ans_5ans : 1cac
2/j

5ans_12ans : 1cac 3/j

>12ans : 2cac 3/j

3 SRO

4 +/- Flagyl : 30mg/kg/j pdt 7j

■ Sirop : 125mg (Nrs)/ 200mg (Enfant)

1cam 3/j

■ Cp : 1cp 3/j

250mg : >13ans

Hépatite A

● Clinique:

Notion de contagé, douleur abdominale, ictère, vomissements, fièvre, tableau de gastroentérite, asthénie, prurit, photophobie, céphalées, prurit, urines foncées, syndrome pseudo grippal..

Hépatosplénomégalie

■ Bilan: 

■ FNS

■ VS/CRP

■ Gly

■ Sérologie:

■ HIV

■ HVC

■ HVA

- HBS

- ASAT/ALAT

- GGT/PAL

- TP

- Si $<50 \Rightarrow$ Insuffisance hépatocellulaire $\Rightarrow$

Orientation

- $>50 \Rightarrow$ forme bénigne

- Hépatique:

- ASAT/ALAT: $10 \times$ normal

- Bilirubine total  conjugué ++

- Sérologie IgM: HVA

- Échographie $\Rightarrow$ Hépatomégalie

✓ Traitement:

- Repos
- RHD (légumes et fruits, éviter les produits laitiers et gras..)
- Éviction scolaire
- Symptomatique
- Éviter Paracétamol

Hépatite B

● Clinique:

Digestifs, ictère, hépatomégalie, Éruptions cutanées, asymptomatique..

- Bilan hépatique complet:
- TP: (-) 50=> Fulminante
- ASAT/ALAT
- Bilirubine Total/indirecte/directe

- Sérologie complète:
- VIH, HCV, HAV
- Charge virale
- Fibroscan

- Selon les résultats on décide si on donne le traitement ou pas: Ig/Vaccination

→ Orientation infectieux

PRINCIPALES ORIENTATIONS

selon le degré de cytolyse

ALAT < 5 N	ALAT 5-15 N	ALAT > 15 N
- Hépatites B et C - Alcool - Stéatose non alcoolique (NASH) - Génétiques . Hémochromatose ++ . Maladie de Wilson . Déficit Alpha-1 antitrypsine (PiZZ) - Hépatite auto-immune - Médicaments, plantes...	- Causes précédentes - Hépatites aiguës . A (IgM) . B (Ag HBs, IgM anti-HBc) . C (si + : ARN du VHC) . voire E (IgM)	- Causes précédentes - EBV, CMV, herpès - Acétaminophène (paracétamol) - Foie ischémique

Claude EUGENE

8

PRINCIPALES ORIENTATIONS

selon le type de cytolyse

Hépatique ALAT > ASAT	Hépatique ASAT > ALAT	Non hépatique ASAT > ALAT
- Stéatose et NASH - Hépatite virale - Médicaments - Amanite - Génétiques - Auto-immune - Maladie coeliaque - Obstruction biliaire aiguë - Maladie veno-occlusive, SOS - HELLP, stéatite gravidique - Sepsis	- Alcool - Cirrhose (quelle qu'en soit l'étiologie) - Foie ischémique - Foie congestif - Budd-Chiari aigu - Nutrition parentérale totale	- Musculaire (dont le muscle cardiaque) - Hémolyse - Endocrinienne : . Thyroïde . Insuffisance surrénale - Foie ischémique - Coup de chaleur

Claude EUGENE

9

Hoquet

● Clinique :

Réflexe ventilatoire caractérisé par une succession de contractions inspiratoires spasmodiques, incontrôlables et involontaires

RGO, tabac, cancer, pancréatite, HIC, iléus post op, diabète, IR, AVC, stress, anxiété..

- Ionogramme sanguin : Hypokaliémie
- ECG + Troponines : IDM
- TLT : Pneumonie, hernie hiatale
- Échographie ou scanner AP si non :
- TDM cérébrale : Atteinte neurologique centrale

✓ Traitement :

1 Primperan inj 10mg en IM 1/j puis relais

2 Primperan cp 10mg 1cp 3/j

1/4h avant repas jusqu'à l'amélioration des symptômes

Ou Zophren

Ingestion de caustique

 Hospitalisation :

- Arrêt de l'alimentation orale
- Bilan d'urgence
- ASP ■ TLT

 A ne pas faire :

- SNG
- Vomissements
- Neutraliser le caustique

 Traitement :

- Mopral 80mg 1mg/kg 2/j
- Solumedrol 60_80mg
- Réhydratation
- TDM si adulte

 Avis Gastrologie

Ingestion de l'eau de Javel

- Brûlure caustique >100cc
 - Arrêt de l'alimentation
 - Réhydratation

 - ASP => si RAS
 - TLT

 - Si épigastralgies
 - Mopral (Enfant => 1_2mg/kg/j) diluée dans 250cc de SG5% ou SSI9%
- Adulte : 1amp
- Enfant : ½ amp
- Ou Spasfon
-
- + 0.15mg/kg de Zophren en IVL

✓ Traitement de sortie :

- Antispasmodique type Timonal sirop
- Surveillance pdt 6h

Ingestion d'une pièce de monnaie

- Examen clinique + TLT + ASP
- Si non ASP debout prenant le thorax
- Si la pièce est au dessus de clavicule :
 - ☐ Avis ORL en urgence
- Si au dessous (digestif) : Surveillance

- Asphyxie ou détresse respiratoire :
 - ☐ Evacuation en urgence
- Contrôle chaque 48h

Ingestion d'une pile

■ Symptômes : Dysphagie, toux, hypersalivation, fièvre, modification de la voie..

🚑 Signes de gravité : Pâleur, malaise, vomissements, détresse respiratoire, instabilité hémodynamique

■ Extraction avant 2h (s'il dépasse 2h risque de complication) par fibroscopie haute

A vissé diagnostique (visualisation des lésions) et thérapeutique (extraction)

⊖ Complications :

Sténose œsophagien

Sténose sous glottale

Sténose trachéal et fistules

■ Miel >1ans : 10ml/10mn ou Sucralfate 10ml

06 doses avant l'arrivée à l'hôpital et 03 doses durant l'hospitalisation

☑ CAT :

■ Mopral/Antiémétique

■ Arrêt de toute alimentation orale

■ TLT

■ ASP

■ Bilan :  sanguin d'urgence

■ Monitoring : Ta/Fc/Fr/SaO2/ECG

➡ Avis Gastrologie et CCI

Intoxication alimentaire

 En urgence : Adulte

Flagyl 500mg + Spasfon 1amp

+ Primperan 1amp si Vomissements

 Pas d'antidiarrhéiques

 Traitement de sortie : symptomatique

Spasfon cp 160 1cp 3/j

■ Si fièvre :

Bactrim 1cp 3/j pdt 7j

Ou Flagyl 500mg 1cp 3/j pdt 7j

■ Si signes de gravité : Bilan 

■ FNS

■ CRP

■ Rénal

■ Ionogramme

■ Femme enceinte 

1 Zomax cp 500mg

2 Spasfon cp 80mg

3 Domperidone cp 10mg

Ou Primperan

■ Enfant  :

1 Spasfon 80mg

2 Vomiteb si Vomissements

+/_ Flagyl 250mg

Maladie coeliaque

● Clinique :

- Ballonnement, constipation, vomissements, dyspepsie, appétit ↓, asthénie, arthralgies...

- Associations :

Anémie ferriprive, carence en B9, aphtose buccale, Fractures, douleurs osseuses, dermatite herpétiforme, DID, dysthyroïdies

- Diarrhées avec stéatorrhées

- Douleurs abdominales

- Syndrome de malabsorption

- Enfant et nourrisson +++

- Sérologie :
- Ac Antiglutaminases AGT (diagnostic et dépistage)
- Antiendomysium AEM (Confirmation)
- AntiDGP (test de choix)

■ Bilan : 

■ IgA total

■ Ac antitransglutaminases IgA

■ Compléter par Fibroscopie + Biopsie

✓ Traitement : RSG à vie

Occlusion intestinale aigue

● Clinique :

Douleur abdominale, vomissements, nausées, arrêt des matières et des gaz, Météorisme ou ballonnement abdominal, défense ou contracture, orifices herniaires

Percussion : Tympanisme, matité des flancs

Rechercher : cicatrice de laparotomie, mouvement de peristaltisme

- ASP=> NHA
- Confirmer par TDM
- Bilan :  pré op
- FNS : Hyperleucocytose
- Gly
- TP/TCK

- Urée/Créat
- ECG
- TLT
- Ionogramme : Hypokaliémie

✓ Traitement :

- Antalgique Antispasmodique
- ATB

→ Orientation Chirurgie



Omphalite

● Clinique :

Rougeur, douleur, tuméfaction, sécrétions au niveau de l'ombilic

- Échographie en 1^{ère} intention : Abdominale + parties molles

- NRS : pour éliminer un kyste de l'ouraque, malformation congénitale...

Si anomalie=> Avis CCI

- Adulte : pour éliminer un abcès, tumeur abdominale..

✓ CAT :

- Soins locaux : Nettoyage au SSI

- Eau Oxygénée/Eosine aqueuse avec du coton tige

- Fucidine pmd 2/j pdt 21j Ou Infectoban crème 2/j

- Fongique :
- Eau oxygénée
- Econazole crème pdt 15j

- Bilan 
- FNS
- CRP/VS
- Glycémie à jeûne
- HBA1C
- Urée/Créat
- ECB du pus

Oxyurose

● Clinique :

Prurit anal nocturne majoré par le grattage
parfois vulvo vaginite chez la fille, récurrence +++

Confirmer par: scotch test le matin sur la marge
anale

✓ Traitement:

- RHD + traitement de toute la famille
- Couper les ongles et laver les mains
- Changement des vêtements chaque matin
- Fluvermal sirop 1cac une seule prise: J1J2J3

A renouveler le J15

Ou cp 100mg 1cp/j

- Si Oxyurose confirmé (scotch test) => prise en J1 et une prise en J15
- Si c'est pas confirmé => prise en J1J2J3 puis en J15

Ou Verzol (Verten) cp 400mg ou susp buv 4 %
1cp Ou 1cam/j à renouveler (en J1 puis J7)

Ou Combantrin 125mg sirop/cp 10mg/kg

A renouveler après 15j.

- La présence des verres longs:

Helmentex sirop 1cam/10kg une dose

A renouveler après 20j

Helmintox: Adulte: 250mg Enfant: 125mg
cp/sirop

- Coproparasitologie des selles

■ Femme enceinte 🤰

Cambantrin 10mg prise unique à renouveler
après 15j

Ou Helmintox



Pancréatite

● Clinique :

- Douleur (Tonner dans un ciel serein)
épigastrique aigue permanente à irradiations dorsale, soulagée par l'antéflexion (position en chien de fusil) => nausées, vomissements, ictère anorexie, ecchymoses, signe Gullen.

- Terrain :

Obèse, âgé >80ans

- Echographie

- TDM

- Bilan :

- FNS/Gly/Rénal/Ionogramme/PA/GOT/GPT/LDH

- Lipasémie >3N

- TG ↗

■ALAT $\nearrow$ 3N : origine lithiasique

■Ca $\searrow$

■Bilirubine $\nearrow$

✓ CAT :Hospitalisation

■VVP/arrêt de l'alimentation

■Antalgique 1amp Spasfon en IVD

■Sonde NG si Vomissements

■Réhydratation

■Correction des troubles hydrolytiques

■Nutrition IV

■Lithiasique $\boxed{\rightarrow}$ Chirurgie si non médecine interne



Péritonite

● Clinique:

- Douleur, vomissements, arrêt des matières et des gaz, troubles urinaires, polypnée, hypoTA, pouls ↗ fièvre +++
- Contracture, ventre en bois
- Percussion: Tympanisme, matité des flancs
- TR: Douleur vive
- Bilan: 
- FNS: Hyperleucocytose
- Rénal: IR fonctionnelle
- Ionogramme: Déshydratation
- Acidose métabolique
- TLT: pneumopéritoine, épanchement pleural
- ASP: pneumopéritoine

- Échographie: Épanchement péritoniaux, Abscès

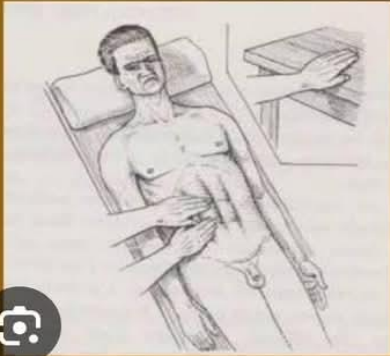
✓ CAT:

- VVP: Rééquilibrage hydro électrolytique

- ATB à large spectre

→ Chirurgie

Rôle de l'IDE en préopératoire
Affirmer le diagnostic



1 signe pathognomonique :
La contracture
(ventre de bois)

Douleur abdominale
Occlusion fonctionnelle

RGO

● Clinique :

- Pyrosis : brûlure épigastrique rétrosternale ascendante

- Régurgitations acides : remonté passive de contenu gastrique dans la bouche

Survenue postprandial des symptômes

↗ en décubitus ou antéflexion (signe de Lacet)

- Signes d'alarme :

- Dysphagie, Odynophagie

- Anémie ferriprive, hémorragie digestive

- AEG, Amaigrissement

- ATCD d'ulcère ou chirurgie gastrique

- ATCD familiaux de cancer gastrique

- Masse abdominale

■ <50ans et absence des signes d'alarme :

Pas d'exploration=> traitement d'emblée

■ >50ans et présence des signes d'alarme :

Endoscopie digestive haute

Si normal=> Ph métrie

✓ CAT:

■ RHD: ☐ poids, arrêt du tabac et alcool

■ Régime alimentaire

☐ 1 Maalox sirop/Gaviscon:

Sirop/Sachet 1càs ou 1st 3/j après chaque repas et au coucher, si besoin en cas de Pyrosis ou Régurgitations

☐ 2 IPP: Omeprazole 10_20mg 1gel/j pdt 1mois

Ou Azentac cp 300mg 1cp/j le soir

■ Enfant 🧒 :

1 Gaviscon sol buv 1ml/kg/j donc 1cac 3/j
15min après les repas.

2 Mopral gel 10_20mg 1mg/kg/j 3/j avant repas

Rupture des varices œsophagiennes

Principale cause d'hémorragie digestive haute liée à l'hypertension portale chez les patients atteints de cirrhose..

- Bilan : 
- FNS
- Groupage
- TP
- Prise de TA (retentissement clinique et biologique)

- ✓ CAT :
 - Stabiliser le malade (Remplissage SSI, Transfusion cible Hb à 8)
 - Si TP bas : Vitamine k 5mg /j en IV pdt 3j
 - Sandostatine 600 Ug diluée dans 50cc SSI en pousse seringue ; débit 2cc/h pdt 72h

- Mopral
- Claforan 1g 2/j
- Flagyl 500mg 3/j
- Lactulose sirop (1càs 2/j) pour prévenir l'éncephalopathie hépatique chez les cirrhotiques
- Surveillance clinique et biologique

→ Evacuer pour endoscopie digestive haute avec éventuelle séance de ligature

Spasme gastrique postprondial sans RGO

● Sensation de douleur spasmodique après le repas

✓ Traitement :

1 Esophton gel 30mg 1gel/j le matin à jeûne

2 Pepsen sac 1sac 3/j

3 Phosphalugel sac 1cas 3/j

Ou Effidigest/Rapidigest/Meteospasmyl

■ FOGD

Ulcère gastro duodénale UGD

● Clinique :

- Douleur ulcéreuse épigastrique type Brûlure sans irradiations, postprandiale tardive, nocturne, rythmée par les repas, lait, alcalins
- Rechercher une prise des AINS, Aspirine, tabac
- Diagnostic : FOGD

✓ Traitement :

1 Lisinox cp 40mg : 1cp 2/j 14j puis 1cp/j 3_5sem

Ou Oméprazole gel 20mg : 1gel 2/j pdt 14j
Puis 1gel/j 3_5sem

2 Amoxicilline cp 1g 1cp 2/j pdt 14j

3 Clarithromycine cp 500mg 1cp 2/j pdt 14j

4 Flagyl cp 500mg 1cp 2/j

■FOGD de contrôle après fin du traitement

⊖ Éviter : AINS/stress/tabac..

Vomissements

● Clinique :

- Éliminer une urgence chirurgicale : douleur abdominale, défense, contracture, arrêt des matières et gaz=> ASP/échographie.
- Éliminer une urgence médicale :
 - Vomissements + photophobie + céphalée => HIC
 - Vomissements + Fièvre => Méningite (PL)
 - Vomissements + Fièvre + diarrhées => Gastroentérite
 - Acidocétose diabétique
- Ionogramme : pour éliminer une cause métabolique

✓ CAT :

■ Antiémétiques 15 min avant repas +
Réhydratation orale

■ Motilium sirop dose/kg 3/j

■ Vogalene sirop dose/kg 3/j

Ou suppo ½ <6ans 1suppo 3/j

Ou gel 15mg 1gel 1_2/j

■ Primperan 1gtt/kg 3/j ou cp 5mg

⊖ CI si Épilepsie/Parkinson

■ Domperidone cp 10mg/sirop 1mg/ml 1cp 2_3/j

Max 30mg/j 15min avant repas pdt 7j

>12ans, >35kg

⊖ A éviter >60ans, avec comorbidité

■ Femme enceinte

Vomiteb sirop 3/j 20min avant repas

Ou Vogalene suppo 2/j

Ou Vogalys cp

Ou Primperan inj

Genesia

■ Sujet âgé :

■ ECG : pour s'assurer que y a pas un TDR
(allongement de QT surtout, arythmie..)

Absence d'IH

■ Si Non : Durée max => 3j

■ Domperidone sirop, Vogalys cp, Vomiteb sirop
ou cp

■ Enfant 🧒 :

■ Vomiteb sirop 1ddp 3/j

■ Vogalene suppo 5mg 1mg/kg 3/j

■ Primperan >1ans

■ Domperidone sirop : >12ans ou 35kg : 1ddp 3/j

+ SRO St

1st dans 1l d'eau brouiller puis refroidir

2cas après chaque vomissements

